EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88244
SERVICIO : AREA QUIRÚRGICA HSC
FECHA : 2024-07-09 15:15:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GUILLERMINA BASTIAS MARTINEZ			**RUN**	: 6.948.230-9
F.Nac	: 08-09-1949	**Edad**	: 74 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: LUIS CRUZ MARTINEZ 750			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 967336778		
Fecha Ingreso	: 2024-06-27	**Fecha Egreso**	: 2024-07-09 15:15:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. TEP lobar y segmentario derecho, sin signos de sobrecarga ventricular. - PESI Clase V, Muy alto riesgo (154 puntos)
2. HDA - Lesión gástrica ulcerada de aspecto neoplásico (En espera resultado biopsia)
3. ACV Isquémicos múltiples territorios cerebrales (ambas CP, Bicerebeloso, Frontal izquierdo)
4. Antecedentes: HTA, Hipotiroidismo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, Hipotiroidismo, inicia cuadro clínico el 21.06.24 am al despertar, encontrada por familiares somnolienta y desorientada, consultan en urgencias, se enfrenta como constipación, diagnostica fecaloma, se realiza enema fleet + manejo ambulatorio, en domicilio el 22.06.24 comienza con deposiciones negras pastosas abundantes que se mantiene previo al ingreso, debido a persistencia de sd confusional es evaluada en extrasistema por neurología, quien solicita RM cerebro (informada 26/06/24) con múltiples ACV isquémicos agudos en distintos territorios sin transformación hemorrágica (ACP completa derecha, occipital izquierda, frontal izquierdo en cuña, cerebelosos bilaterales pequeños), lacunar antiguo cerebeloso derecho y caudado izq, motivo de derivación a urgencias HCHM, donde se complementa con laboratorio destacándo dímero D >20.000, resto laboratorio sin alteraciones significativas. Por red ingresa HSC, en urgencias normotensa, normocárdica, T° 37, normoglicémica, sato2 ambiental 91%, al examen físico sin alteraciones, al examen neurológico con paresia M3 BC derecho, se evalúa inicialmente por UTI quien estima sin criterio ingreso, se deriva a UPAC para manejo. Evaluada por neurología en sala 27.06.24 a las 9 am, paciente en regulares condiciones generales, PAS 120- 130, RS en monitor, afebril, con leve requerimiento O2, sin disnea. Se revisa Rm cerebro, impresionan infartos agudos, sin transformación hemorrágica de características embólicas, además TC tórax s/contraste hoy am con signos sugerentes de TEP basal derecho. Por DD >20000, se solicita AngioTC de Torax: Compatible con tromboembolismo pulmonar agudo lobar y segmentario derecho, sin signos de sobrecarga ventricular. Pequeño infarto esplénico de aspecto agudo. Adenopatías infradiafragmáticas sospechosas. Sin melena durante la mañana 27/06/24. Por gravedad de patologías agudas, se solicita reevaluación por Residente UTI, se indica ingreso a UTI + EDA coordinada con Dra Acero. Se realiza EDA, se pesquisa lesión excavada y ulcerada de aspecto neoplásico en angulo gástrico, se toman Biopsia. Evoluciona hemodinamicamente estable, sin necesidad de apoyo con DVA. Ingresa con diagnostico de TEP lobar y segmentario derecho en el contexto de HDA, se mantiene en observacion durante 48 hrs, se inicia anticoagulación el 29/06/24 con BIC de HNF, ante ajuste dificil para rango terapeutico de TTPK, se decide anticoagulación con Enoxaparina desde 02/07. Hoy inicia

dabigatran. Ventilando espontaneo, con requerimiento de FiO2 adicional desde su ingreso, se logra destete progresivo, se suspende definitivamente O2 adicional el 04/07 durante la mañana. Afebril, ingresa con parametros inflamatorios bajo, en el transcurso de los dias con tos productiva de via area superior, se toma CSB negativo como sospecha de Traqueobronquitis; Se revisa en sistema, tiene UC 24/06 (+) E coli, luego UC 27/06 negativo. Ante alza de PI, se decide inicio de Ceftriaxona por UC (+) del 24/06. CSB 29/06 negativo. HC negativo. Funcion renal sin conflicto, metabolicamente estable. Completo tto Ceftriaxona 8 dias al 08/07. Se converso con neurología se considera necesario anticoagulación en contexto de AVC multiembolico y TEP, y considerando estabilidad o no sangramiento intestinal actual.
Se converso manejo de anticoagulación con familiares, para continuar en Hodom con enoxaparina 60mg C/12 hrs sc, mas neurorehabilitacion kinésica y fono. Y además con vigilancia de signos de sangramiento, por ello se decide HODOM y control medico Hodom al cabo de 1ª semana, para definir continuidad anticoagulación sc, traslape a taco oral, o alta definitiva.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido por kinesiologo
2. Regimen blando hiposodico a tolerancia
3. Rehabilitacion integral: kine y fono (ideal kine 2 veces al dia)
4. Omeprazol 20mg al dia vo
5. Enoxaparina 60mg sc c12h
6. Paracetamol 500mg 2 c/8 hrs vo SOS
7. Lactulosa 20 cc c/8 hrs vo
8. Resto Tttos cronicos reiniciar y mantener
9. Rescatar biopsia gastrica en 20 dias aprox
10. AL ALTA CONTROL NEUROLOGIA (ACVs) Y MEDICINA (TEP Y HDA) (2 A 3 SEMANAS POST HODOM),
11. SEGUN RESULTADO BIOPSIA ESTOMAGO SIC PARA CONTROL CON CIRUGIA
12. SOS CONTROL VIA URGENCIAS

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO